

복부초음파에서 자주 나오는 소견

검진이나 진료 중 복부초음파에서 간·콩팥의 물혹, 담석, 담낭용종이 종종 발견됩니다. 대부분 크게 걱정할 소견은 아니지만, 언제는 지켜보고 언제는 추가로 확인하는지 정리했습니다.

간 물혹과 콩팥 물혹

간 물혹 — 단순 물혹은 임상적으로 의미가 크지 않습니다

간의 단순 물혹은 흔히 발견되며, **임상적으로 의미가 크지 않아** 증상이 없으면 치료 없이 지켜봅니다.

벽이 두껍거나 모양이 애매하면 추가 영상검사를 상담합니다.

콩팥 물혹 — 단순 물혹은 위험도가 높지 않습니다

단순 물혹은 위험도가 높지 않습니다. 다만 **격벽(물혹 안의 칸막이)·벽 두께·조영증강 부분을 보고 보즈니아(Bosniak) 분류**로 위험도를 나누는 것이 중요합니다.

격벽이 보이거나 복잡하면 CT·MRI로 분류를 확인합니다.

담석 — 증상 없으면 관찰합니다

증상이 없을 때

증상이 없는 **담낭 담석**은 대부분 바로 수술하지 않고 관찰합니다.

담석이 **3cm를 넘으면** 증상이 없어도 수술의 이득과 위험을 상담할 수 있습니다.

통증이 생기면

기름진 식사 뒤 **오른쪽 갈비뼈 아래나 명치가 쥐어짜듯 아프면** 외과 진료를 상담하세요.

통증이 계속되거나 **열이 함께** 나면 예정된 진료를 기다리지 말고 빨리 오세요.

담낭용종과 초음파의 한계

담낭용종

1cm 이상이면 수술을 상담하고, 작으면 **1년마다** 크기를 봅니다.

추적 중 저절로 없어지기도 합니다. 크기별 세부 기준은 '**담낭 폴립 추적 안내**' 유인물에서 자세히 안내합니다.

초음파의 한계

복부초음파는 장 속 공기에 가려 **췌장은 일부만** 보일 수 있습니다.

검사 전 **금식**하면 담낭이 잘 퍼져 더 정확하게 보입니다.

흔한 오해

"담석이 있으면 무조건 수술해야 한다" → 증상이 없으면 대부분 관찰합니다.

"초음파로 복통 원인을 다 알 수 있다" → 장 속 공기에 가려 일부만 보일 수 있어, 필요하면 다른 검사를 함께 봅니다.

빨리 진료가 필요한 경우

오른쪽 윗배 통증이 계속될 때 — **열이나 황달**이 함께 생기면 응급실로

콩팥 물혹이 있는 분에서 **혈뇨, 발열, 새로 생긴 옆구리 통증**이 있을 때

